

IFSC Garopaba: Uso de jogos eletrônicos para saúde mental.

Gustavo de Oliveira Silveira, Gabriel Marques de Campos, Mateus Lucinei Silvano, João Cícero Barreto Machado, André Luiz Silva de Moraes.

¹Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Garopaba (IFSC)

Rua Maria Aparecida Barbosa, 153

CEP 88495-000 – Garopaba – SC – Brazil

gustavo.os@aluno.ifsc.edu.br, gabriel.m13@aluno.ifsc.edu.br, mateus.l2002@aluno.ifsc.edu.br,
joao.cbm@aluno.ifsc.edu.br, {andre}@ifsc.edu.br

1. Introdução

Atualmente um dos maiores assuntos da sociedade é a saúde mental, e, como todos sabemos estamos em uma época que os jogos eletrônicos estão em alta, nosso projeto tem como objetivo relatar por meio de estudos de caso, a influência dos jogos na saúde mental, tanto positivamente quanto negativamente. Principalmente entre o público jovem.

Muitos se tornam anti-sociais esquecendo as suas responsabilidades e deveres, com ansiedade e outros tipos de problemas que ocorrem devido ao uso excessivo de jogos eletrônicos.

Mas um uso saudável de tais jogos pode também produzir resultados positivos caso usado com moderação. Como mais habilidades sociais, assimilação de novos ambientes, culturas, histórias e vocábulos.

2. Metodologia e Desenvolvimento do Projeto

Para o desenvolvimento do projeto, procuramos notícias, artigos e matérias em que relacionam a questão da saúde mental, que é pouco comentada pelas pessoas, com os jogos eletrônicos.

Analisamos o impacto dos jogos eletrônicos na saúde mental e o uso excessivo de dispositivos tecnológicos e a compulsão por games são um problema de saúde pública. Além de ter grandes chances de afetar seriamente a saúde mental e física do indivíduo, a dependência por jogos eletrônicos ou virtuais também traz prejuízos no âmbito social, familiar, educacional e profissional.

Mas em contrapartida muitas pessoas conseguem se beneficiar com jogos, de modo que a sanidade mental aumenta até mesmo o humor. Em meio às pesquisas descobrimos que esse tema é muito abordado por instituições grandes e de importância na sociedade, um modo de melhorar esses problema é ficar entre esses dois problemas, o excesso e o pouco, os jogos hoje em dia tem um potencial muito grande na humanidade ou seja se controlarmos a carga horária do jogo e de algum modo não sejamos dependentes nem isentos dos jogos no dia a dia.

Além desse modo existem algumas práticas que deveriam ser mais bem utilizadas como atividades físicas, além de melhorar a saúde física melhora a saúde mental trazendo vantagens e benefícios que duram o resto da vida, manter alimentação saudável já que muitas das vezes pessoas dependentes de jogos são isentas as vezes de alimentação regular por conta da obsessão de jogar cada vez mais, cuidar da qualidade do sono é um ponto importante pois o sono regular traz energia para cada dia, um corpo sem a energia suficiente para durar o dia trás desde indisposição até doenças físicas, manter também relacionamento saudável pois muitos que entram no mundo dos jogos acabam criando um hábito anti social e acaba tirando a necessidade da pessoa de falar em público ou com pessoas ao seu redor.

2.1 Estudo de Caso

2.1.1 Vídeo game na saúde e reabilitação.

O intuito é explorar os jogos para além de seu uso educacional, analisando se os mesmos constituem ferramentas para intervenção no campo da saúde mental. Consiste na utilização de um ou mais métodos qualitativos de recolha de informação e não segue uma linha rígida de investigação. As análises de extratos de diários de campo das oficinas de jogos possibilitaram apontar que a experiência de jogar pode oferecer novas condições para a experimentação de si, dando ocasião à instituição de uma função normativa, capaz de produzir novas normas de vida e de relação. As oficinas se tornaram um espaço terapêutico de destaque a partir da reforma psiquiátrica, por pressupõem uma posição ativa dos participantes. A justificativa para seu uso é a de que as oficinas terapêuticas permitem que o paciente psiquiátrico acesse atividades laborais, artísticas e comunicativas com o intuito de uma reinserção social.

Jogos como dispositivos promotores de saúde.

Estabelecer algumas diretrizes para a continuidade dos estudos que buscam analisar se videogames constituem dispositivo de trabalho na saúde mental de crianças e adolescentes. Podemos propor que o adoecimento pode ser pensado, como a perda de capacidade normativa, “a capacidade de instituir outras normas em outras condições”. a experiência de jogar pode modificar essa capacidade, ofertando novas condições, então, os videogames, por suas características, poderiam constituir uma experimentação de si, ao instituírem uma função normativa.

O humano detém uma organização autopoietica mais complexa por ser um ente, ao mesmo tempo, bicultural, provido de linguagem e consciência. Assim, a autopoiese humana significa uma complexificação da capacidade de reordenar seus componentes em uma nova organização. Saúde implica, portanto, uma manutenção da autopoiese; doença, um ataque à organização autopoietica, e, morte, a perda total dessa capacidade. Nessa linha, saúde não pode ser definida ou caracterizada, simplesmente, pela presença de componentes (como um vírus,

uma baixa reputação em determinadas sinapses ou baixa autoestima), mas pela capacidade de auto ordenar esses componentes numa nova organização existencial. No ser humano, a organização autopoietica tem uma complexidade que engloba as dimensões corporal, psíquica e social. Ser sadio significa ser reativo e autônomo diante de agentes e situações perturbadoras do equilíbrio existencial. Nesse sentido, sadia é aquela pessoa que consegue de tal maneira integrar, na própria vida, as perturbações do bem-estar físico, psíquico e social.

Nossa segunda proposição aponta para a constituição de distintas regras de funcionamento. No videogame, o jogador é imerso em um sistema de regras específico do jogo. Esse conjunto de regras pode ser diferente de outros sistemas de regras com os quais ele tem contato em seu cotidiano. Por exemplo, em jogos de tiro em primeira pessoa, ocorre um deslocamento normativo da ação de matar, pois não se trata de aniquilar o adversário, mas, sim, de vencê-lo. Desta forma, o que ocorre no videogame não se refere a uma violência contra o outro, entre personagens no jogo.

Neste sentido, alguns jogos possuem características que possibilitam pensar a produção de normatividade, sendo também entendida como produção de saúde. Experiências com jogos que possuem proporções incontáveis de combinações de ações permitem possibilidades também incontáveis de instituição de novas percepções de si e, com essas, novas normas de vida e de relação, intervindo nos modos de subjetivação dos jogadores.

Oficina com games em um serviço de saúde mental.

As oficinas se tornaram um espaço terapêutico de destaque a partir da reforma psiquiátrica, por pressupõem uma posição ativa dos participantes. A justificativa para seu uso é a de que as oficinas terapêuticas permitem que o paciente psiquiátrico acesse atividades laborais, artísticas e comunicativas com o intuito de uma reinserção social.

Retomando a questão do estudo, as idades dos participantes variaram entre sete e 17 anos. As oficinas tiveram periodicidade semanal, com duração média de uma hora e trinta minutos. Cada grupo era composto por cinco participantes, que correspondia ao número de computadores disponíveis no laboratório. As oficinas foram acompanhadas por dois ou trêsicineiros, sendo que, pelo menos, um deles era um técnico do serviço e os outros participantes do projeto de pesquisa. A oficina era estruturada em três momentos: no primeiro deles, havia uma conversa sobre a proposta do dia (dar continuidade a um trabalho anterior; criar uma nova produção; trabalhar em grupo ou individualmente). O segundo momento consistia na realização da oficina, e, finalmente, o momento final, de compartilhamento, no qual os participantes relataram ao grupo o trabalho desenvolvido. Nas oficinas era possível evidenciar que, apesar da vibração das crianças e adolescentes, a imersão em uma experiência planejada significa, em um primeiro momento, criar acoplamentos com o mesmo. A imersão, como a definimos: a efetivação de um acoplamento estrutural, é resultante de uma

operação na qual as ações encontram congruência e sentido nos mundos onde se efetivam. Para Maturana, ao invés de representarem um mundo independente da ação, os sistemas cognitivos configuram mundos como domínios de distinções, inseparáveis das estruturas de nossa corporeidade sensório-motora, de nossas emoções, linguagem e instituições. Desta forma, possuímos tantos espaços imersivos quantos acoplamentos estruturais possamos realizar.

Jogar implica coordenar ações e compartilhar sentidos com o jogo e com os demais participantes do mesmo, seja para vencer ou para construir alternativas de existência nesse mundo. O processo de acoplamento demanda treino e afinação, o que faz que os iniciantes, por vezes, explorem muitos jogos antes da imersão tornar-se efetiva.

Produzindo um deslocamento dessa proposição, optamos pelo uso de oficinas como uma intervenção que coloca, em primeiro plano, um fazer compartilhado, que desestabiliza a relação tradicional entre saber e fazer, uma vez que o conhecimento técnico – das disciplinas vinculadas à saúde – pode ser colocado entre parênteses, no que se refere às ações desempenhadas na oficina. O que está em evidência é o fazer em conjunto. Toda a oficina é centrada no compartilhar, na ideia de um espaço em comum que permite o encontro dos participantes com um modo de organização específico. Simultaneamente, tomamos a oficina como dispositivo de pesquisa, uma vez que ela nos permite acompanhar uma processualidade que ocorre a partir de uma determinada configuração de elementos que atuam ao mesmo tempo, não nos limitando apenas ao produto final. No desdobramento das atividades da oficina, existe uma disposição de materialidades, ideias e sentimentos que podem ser percebidos, propostos e retomados a cada encontro. Os encontros não se definem unicamente pelas características dos objetos materiais que guiam o fazer de cada oficina – no caso, os videogames –, mas, também, o modo como estão disponibilizados e a maneira como os participantes se dispõem à ação constituem um domínio que se delinea a cada momento.

Considerações.

A discussão anterior traz evidências de que a experiência de jogar videogames, em um contexto de oficinas, pode fazer emergir percepções de si de forma a se abrirem condições de normatividade nos espaços de afinidade em que ocorrem.

Ou seja, tal como referimos anteriormente, se tomarmos como exemplo os jogos em primeira pessoa, podemos dizer que, nós mesmos, ocorre um deslocamento normativo da ação de matar. Não se trata de aniquilar o adversário, mas, sim, de, ao vencê-lo, incorporar sua potência. Não estamos diante da norma jurídica ou penal, mas da norma do aprimoramento das habilidades. Ao derrotado, cabe a busca de aperfeiçoamento para uma nova batalha. Assim, existe uma função normativa de poder ser melhor do que se era e não a uma norma jurídico-criminal.

As oficinas podem auxiliar os participantes à tomada de consciência de uma dimensão pré-reflexiva da experiência, ao fornecerem oportunidades para a ação em contextos de regras distintas do cotidiano. Osicineiros, ao estimularem e conduzirem o compartilhamento das ações e decisões, capacitam os participantes a tornarem-se conscientes dessa experiência. O compartilhamento, por sua vez, modifica o conjunto de ações pertinentes em um ou mais domínios cognitivos estabelecidos entre os participantes da oficina. Essas modificações permitem uma ampliação do conjunto de respostas às perturbações internas ou externas do bem-estar desses sujeitos. Os videogames constituem espaços participativos e de experimentação de si, pois convidam os jogadores a habitarem novos contextos de experiência, e, portanto, se apresentam como um interessante recurso no campo da saúde mental.

3. Considerações finais

Nossa pesquisa com o intuito de trazer a realidade dos jogos hoje em dia, levando em consideração o vício em jogos eletrônicos entra para a lista de distúrbios de saúde mental sob a nomenclatura “Distúrbio de games” (*Gaming disorder*). Assim como acontece com as dependências químicas, a dependência comportamental também tem altas chances de recaída. E mesmo com o tratamento, o estímulo para continuar a atividade em níveis nocivos continua alto. “O dependente sempre vai ter consigo uma doença, pois a dependência, seja ela química, psicológica ou comportamental, é uma doença crônica, ou seja, nunca se cura. Pesquisar sobre o assunto percebesse que os jogos afetam predominantemente indivíduos do sexo masculino trazendo uma dificuldade para a realização do material, obtendo poucos dados. Mas deixando claro que a criação de jogos para auxílio da saúde mental só vem crescendo nos últimos anos e isso é de grande ajuda, abrindo mais portas pro auxílio da cura de doenças psicológicas que já existem a muitos anos, sabendo disso a indústrias dos jogos tem um papel importante na medicina para um futuro não tão distante.

Referências Bibliográficas

BAUM, Carlos; MARASCHIN, Cleci. Oficinas e jogos eletrônicos: produção de saúde mental?. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 20, p. 1053-1062, 2016.

VANDERLINDE, FERNANDO. **Vídeo games na saúde e reabilitação**. Editora Schoba, 2010.

Betts A, Baum C, Maraschin C, Kveller DB, Medeiros D. Jogos eletrônicos e videogames como e-dispositivos. In: Palombini A, Maraschin C, Rickes S,

organizadores. Tecnologias em rede: oficinas de fazer saúde mental. Porto Alegre: Editora da UFRGS; 2012.

Newman J. Playing with videogames. London: Routledge; 2008.

Gee JP. Good video games+ good learning: collected essays on video games, learning, and literacy. New York: P. Lang; 2007.

Baum C. Sobre videogames e cognição inventiva [dissertação]. Porto Alegre (RS): Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2012.

Gee JP. Why game studies now? Video games: a new art form. Games Cult. 2006; 1(1):58-61.

Maturana HC. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: Editora UFMG; 2001.

Passos E, Kastrup V. Tecnologias, oficina e saúde mental: conversações. In: Palombini A, Maraschin C, Mochen S, organizadores. Tecnologias em rede: oficinas de fazer saúde mental. Porto Alegre: Sulina; 2012. p. 193-219.

Cedraz A, Dimenstein M. Oficinas terapêuticas no cenário da Reforma Psiquiátrica: modalidades desinstitucionalizantes ou não? Rev Mal-Estar Subj. 2005; 5(2):300-27. Araldi E, Piccoli L, Diehl R, Tschiedel R. Oficinas, TIC e saúde mental: um roteiro comentado. In: Palombini A, Maraschin C, Mochen S, organizadores. Tecnologias em rede: oficinas de fazer saúde mental. Porto Alegre: Sulina; 2012. p. 43-58.

Baum C, Maraschin C. Oficinas de vídeo game como dispositivo de compartilhamento em um serviço de saúde mental. Pesqui Prat Psicossoc. 2013; 8(1):95-105.

Squire K. From content to context: videogames as designed experience. Educ Res. 2006; 35(8):19-29.

Thomaz A, Maraschin C, Zaniol E, Schuch E. Dispositivos de imersão em ambientes de realidade virtual. Rev Bras Inform Educ. 2005; 13(2):21-32.

Canguilhem G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária; 1995.

Referências:

<https://www.scielo.org/article/icse/2016.v20n59/1053-1062/>

<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=XePYndf6Xr0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=jogos+eletrônicos+e+saúde&ots=mOWrzWtczs&sig=jvUR0ELzqg7gtC-ROGZFqyogwgk#v=onepage&q=jogos%20eletrônicos%20e%20saúde&f=false>
<http://www.jhi-sbis.saude.ws/ojs-jhi/index.php/jhi-sbis/article/view/539/327>